

CH CORBEIL-OSTEODENSITOMETRIE
116 Boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONS
Service Rhumatologie du Dr Hilliquin

Rapport d'analyse de la composition corporelle

Nom: fdsa dsafd	Sexe: Masculin	Taille: 123 cm
ID du patient:	Date de naissance: 12/07/2000	Poids: 54 kg
Médecin traitant: Doctor	Âge: 22	IMC: 35.69

Résultats

Patient de sexe masculin de âge 22 ans.

Mode de vie

Non Tabagique.

Pas de Consommation excessive d'alcool (plus de 3 verres par jour).

Pas d'Activité physique régulière.

Pas de Supplémentation en vitamine D.

Antécédents fracturaires

Pas d'Antécédent de fracture de faible énergie

Pas de Fracture de fragilité du col fémoral chez un parent du premier degré

Pas de Chutes à répétition

Pas d'antécédent pathologique notable

Pas d'Autres traitements inducteurs de l'ostéoporose

Pas de prise d'un Traitement spécifique de l'ostéoporose

Pas de Corticothérapie pour plus de 3 mois ou reçu depuis au moins 3 mois

Frax: 54%

CH CORBEIL-OSTEODENSITOMETRIE
116 Boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONS
Service Rhumatologie du Dr Hilliquin

Densitométrie osseuse

Région	Z Score	Classification OMS
Rachis AP (L1 - L4)	1.0	Normal
Col du fémur	2.0	Normal
Hanche totale	2.0	Normal
Distal Radius	-	-

Les critères d'interprétation de DMO de l'Organisation mondiale de la santé classent les patients comme

- Normaux: T Score supérieur ou égal à -1.0
- Ostéopéniques: T score entre -1.0 et -2.5
- Ostéoporotiques: T score inférieur ou égal à -2.5

Synthèse

Pas de Fragilité osseuse

[False, 1.0, '->', 'Pédiatrique', 'Tscore>-2']

Source:

+ Recommandations françaises de la prise en charge et du traitement de l'ostéoporose masculine
+ Selon le Protocole National de Diagnostic et de Soins 2019 PNDS

CH CORBEIL-OSTEODENSITOMETRIE
116 Boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONS
Service Rhumatologie du Dr Hilliquin

Traitement Information

Recommandations sur les mesures générales préventives:

- Maintien d'une activité physique régulière, 30 min/jour
 - Recherche de la dose de corticoïdes minimale efficace
 - Assurer un état nutritionnel satisfaisant
 - Contrôle de la maladie causale
 - Traiter un déficit hormonal
 - Bisphosphonates par voie IV (pamidronate ou zoledronate) indiqués si fragilité osseuse symptomatique selon définition (fracture vertébrale et/ou fractures des os longs cliniquement significatives et DMO mineur de -2 Z-score) ou si douleurs osseuses chroniques et DMO mineur de -2 Z-score
 - La posologie et la durée du traitement est à discuter entre les médecins référents de la pathologie et les médecins experts de la santé osseuse
 - Bisphosphonates non indiqués si DMO basse isolée (sans fractures), à discuter au cas par cas dans des centres spécialisés
- Assurer des apports calciques et en vitamine D optimaux: Taux de 25OHD au minimum majeur de 20 ng/ml et de façon optimale majeur de 30 ng/ml associé à un apport de calcium quotidien correspondant aux apports recommandés pour l'âge.

